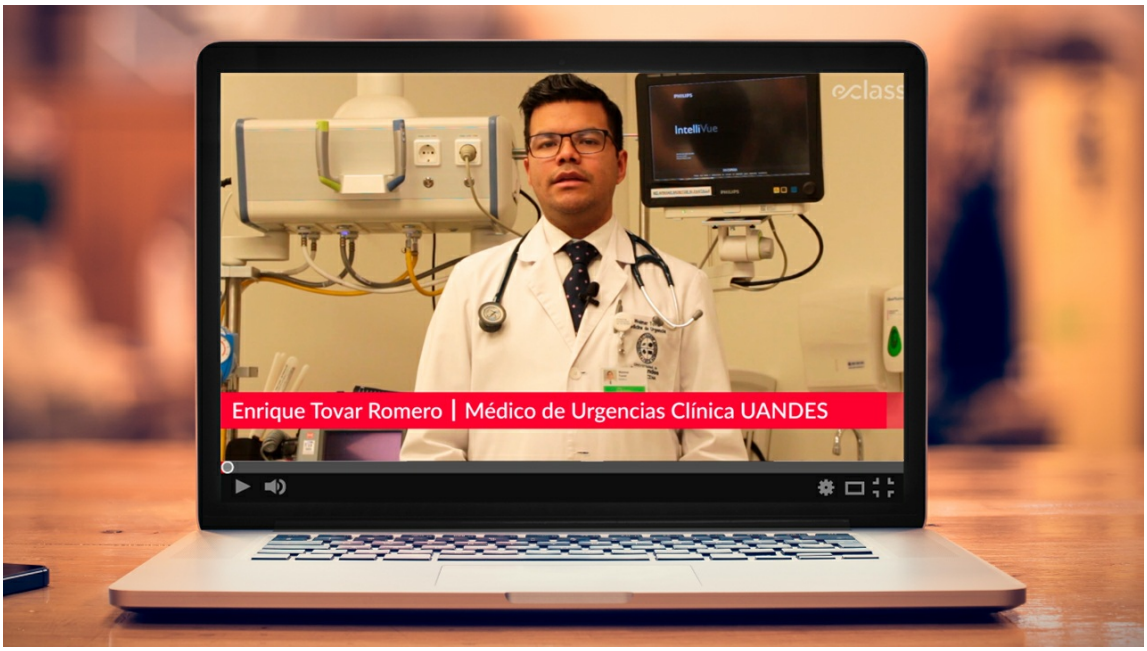
Introducción a la Unidad 3



Vea este video en la versión online de la clase.

Unidad 3: "Daño Hepático Crónico en Urgencia". Elaborada por el doctor Enrique Tovar Romero, Médico de Urgencias UANDES.

Temas de la Unidad

1 | Introducción al Daño Hepático Crónico
2 | Complicaciones en pacientes con daño hepático en el Servicio de Urgencias

Objetivos de la Unidad

1 | Identificar las principales complicaciones del paciente con daño hepático crónico en el servicio de urgencias.
2 | Recordar las medidas terapéuticas iniciales.
3 | Plantear metas en el tratamiento de complicaciones.
4 | Definir el destino del paciente, donde completará su tratamiento.

Daño Hepático Crónico

La enfermedad hepática crónica puede deberse a diversos factores como esteatosis hepática, distintos virus o al consumo de alcohol, con el tiempo este estado produce más daño hepático, llevando a la cicatrización (cirrosis), la que se puede manifestar clínicamente con signos de insuficiencia hepática o de hipertensión portal.

Introducción: Caso clínico

Siendo las 3:00 am en el servicio de urgencia, usted recibe el llamado del servicio de ambulancias. Le informan de un paciente de 50 años con episodio de “hematemesis masiva”, según señalan se encuentra inestable. De la ambulancia avisan que trae doble acceso venoso y que le están aportando oxígeno.

Surgen las siguientes interrogantes:

-¿Debería preparar el reanimador para tratar a este paciente?
-¿Es necesario convocar al equipo de clave azul?
-¿Se beneficiaría de una endoscopía de forma temprana?

Al ingreso al servicio de urgencias, lo traslada al reanimador.

Los signos vitales del ingreso, muestran:
FC 120 lpm, FR 28 rpm, PA 84/55 mmHg, Temperatura 37,5° C Saturación 92% con cánula nasal a 2 lt/min.

Al evaluar en forma general le llama la atención un tinte ictérico generalizado, su abdomen globoso con dilataciones venosas subcutáneas, edema en piernas, y por sobre todo que el paciente está en sopor superficial.

¿Cómo enfrentaría a este paciente que aparenta tener un daño hepático crónico? ¿Cuáles son las complicaciones agudas de estos pacientes?

Definición de daño hepático crónico

Se conoce como daño hepático crónico una injuria prolongada al hígado que puede deberse a diferentes causas pero que producen una progresiva fibrosis y distorsión de la arquitectura del hígado por la formación de nódulos anormales, conocidos como nódulos de regeneración, que en etapas finales se conoce como cirrosis[1] .

La cirrosis es una de las primeras causas de mortalidad a nivel mundial, en Chile según la encuesta nacional de salud existe una prevalencia del 5,2%.

En la clasificación de cirrosis destacan 2 grandes grupos, el primero relacionado con **consumo de alcohol** y un segundo de etiología variada con mención especial a infecciones por **virus de hepatitis B y C.**

Según la encuesta nacional de salud 2017, hay un 11.2% de la población que consume de alcohol de forma riesgosa, lo que conlleva un altísimo riesgo de daño hepático asociado, mientras que la hepatitis B es mucho menos frecuente, tiene una prevalencia de un 0,15% a nivel nacional (ENS 2009-2010).

Dada la gran cantidad de complicaciones en las que destacan hemorragias digestivas, encefalopatía hepática, peritonitis bacteriana espontánea y síndrome hepatorrenal, la expectativa de vida de los pacientes cirróticos se encuentra comprometida.

En el siguiente artículo hablaremos de las complicaciones agudas más frecuentes en pacientes cirróticos a las cuales nos enfrentaremos en el servicio de urgencias.

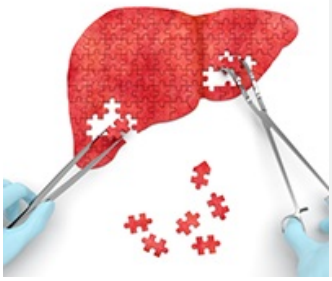
Complicaciones en pacientes con daño hepático en el Servicio de Urgencias

A continuación revisaremos las complicaciones hepáticas más frecuentes en Urgencias, tales como Ascitis, hemorragia digestiva, encefalopatía hepática, Peritonitis bacteriana espontánea y Síndrome Hepatorrenal.

Ascitis

La ascitis, definida como el acúmulo de líquido en el espacio intraperitoneal, es la complicación más frecuente del paciente cirrótico, hasta un 60% de los pacientes la presentarán en los primeros 10 años del diagnóstico de disfunción hepática.

Su diagnóstico, fundamentalmente clínico, se basa en la presencia de aumento de la circunferencia abdominal y ganancia de peso, así como el encontrar onda ascítica y matidez fluctuante en el examen físico abdominal.



Si bien su tratamiento durante la atención ambulatoria, se basa en el uso de diuréticos (espironolactona y furosemida), restricción de consumo de alcohol (en los casos que el daño hepático se relacione a esta causa), hay situaciones que se presentan en urgencias requiriendo intervención a dicho nivel.

Cuando hay presencia de dificultad respiratoria (por aumento de la presión abdominal), ascitis de reciente inicio o sospecha de peritonitis bacteriana espontánea, se hace necesario realizar paracentesis diagnóstica inicialmente, y si se descarta la peritonitis bacteriana con este primer examen, una paracentesis evacuadora para alivio sintomático del paciente en el servicio de urgencias.

Hemorragia digestiva

La cirrosis predispone a que el paciente tenga hemorragias digestivas que pueden consultar a la urgencia tanto por hematemesis como por melenas, con diferentes grados de compromiso hemodinámico.

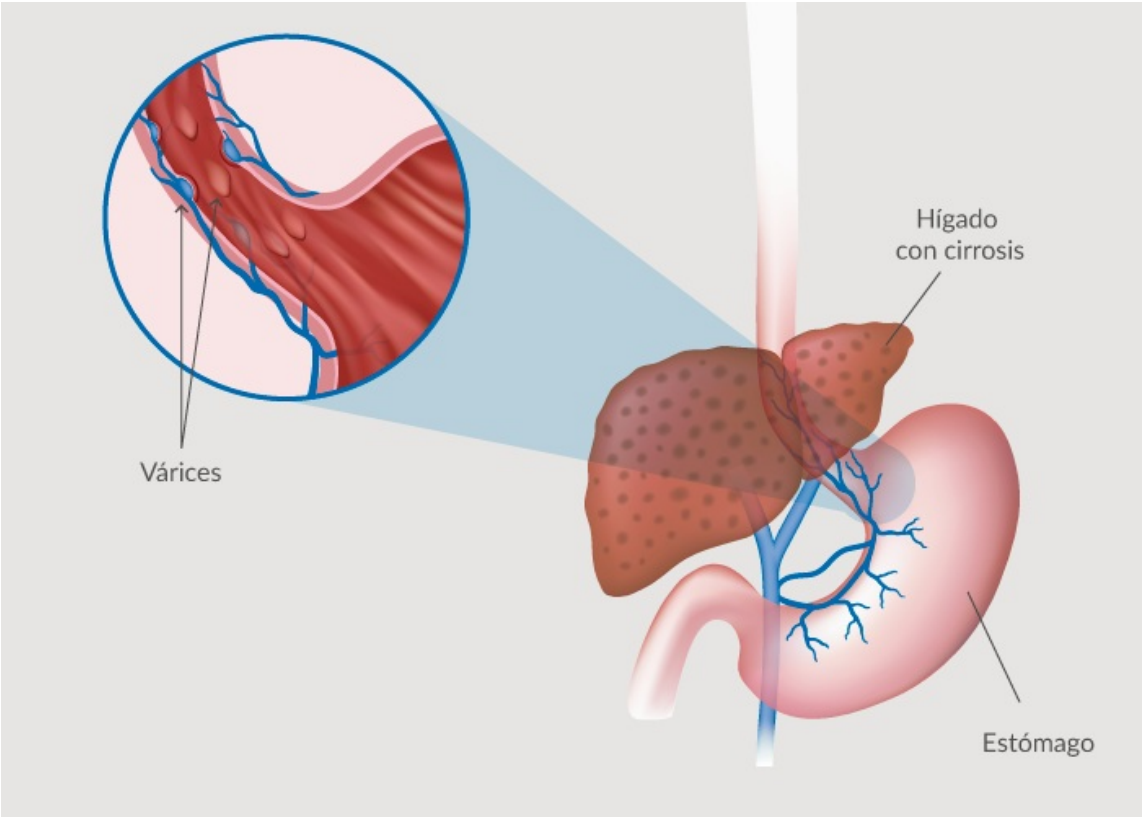
En ocasiones pueden consultar solo por el malestar abdominal asociado a la hemorragia o por síntomas secundarios al compromiso hemodinámico, sin ser clara la presencia de hematemesis ni de melena.

Dentro de los factores que aumentan la probabilidad de sangrado se han descrito:

- Disminución producción de factores de coagulación.
- Disfibrinoginemia, hiperfibrinolisis y deficiencia relativa de vitamina K[1].
- Trombocitopenia[2].
- Disfunción plaquetaria.

Estos episodios de sangrado se deben a lesiones a nivel gastrointestinal que van desde erosiones o úlceras hasta hemorragias variceales, siendo estas últimas las más frecuentes, entre 50 a 90% de todos los casos.

En el paciente cirrótico, la formación de várices va desde un 5% a un 15% por año, de ellos un tercio eventualmente sangrará, y menos de la mitad de los que sangrarán pararán de sangrar espontáneamente. Dichos sangrados presentan una mortalidad de entre un 20% y un 70%, razón por la cual su manejo ha de ser agresivo.



Enfrentamiento inicial

El manejo inicial en pacientes con daño hepático crónico que cursan con hemorragia digestiva, difiere poco del enfrentamiento a aquellos que no presenta disfunción a dicho nivel.

Como primera aproximación se debe considerar evaluar el estado de conciencia y la presencia o no de signos precoces de shock, por lo tanto, primero se indaga si responde o no a estímulos verbales o táctiles.

Manejo en reanimador, paciente crítico

- Monitorear signos vitales (frecuencia cardíaca, presión arterial, frecuencia respiratoria, temperatura), conviene, igualmente, evaluar signos clínicos como estado mental, llenado capilar, intensidad del pulso. Estos hallazgos permiten establecer compromiso hemodinámico inicial.
- Buscar doble acceso venoso (número 14 ó 16, garantizan mayor flujo)[3]. En circunstancias en las cuales el acceso venoso no es posible, el acceso intraóseo es una excelente alternativa.
- Iniciar infusión de cristaloides, infusión inicial de 500 ml, sin diferencia en resultados entre solución salina 0,9% y lactato de ringer.

- Tomar exámenes:
  – Hemoclasificación (la probabilidad de requerir transfusión de hemoderivados es bastante alta, conviene conocer hemoclasificación en forma rápida).
  – Hemograma (si bien los niveles de hemoglboina no se alteran en forma rápida por el sangrado actual, conocer el estado basal del paciente permite orientar metas).
  – Función renal (relación nitrógeno uréico/creatinina mayor a 30, sugiere sangrado digestivo alto).
  – Pruebas de coagulación.

A. Evaluar protección de vía aérea, proteger.

La protección de vía aérea mediante intubación orotraqueal, suele ser difícil en este contexto.

No hay que olvidar la necesidad de preoxigenación y remoción de nitrógeno a nivel intra-alveolar, una alternativa sería el uso de máscara de alto flujo (15 litros por minuto) durante su manejo en reanimador, asociado a una naricera que mantendrá su flujo durante todo el procedimiento.

Ante la presencia de agitación, pudiera ser beneficioso el uso de ketamina para mejorar la comodidad del paciente facilitando la oxigenación y la instalación de sonda nasogástrica, cuya finalidad radica en la decompresión y remoción de contenido gástrico mas NO en el diagnóstico de hemorragia digestiva.

Al momento de realizar intubación orotraqueal se sugieren los siguientes pasos:

1. Preparar elementos para facilitar proceso, recordando que se trata de una situación difícil, como por ejemplo, videolaringoscopio o un *gum elastic bougie*).
2. Instalar sonda nasogástrica para vaciar estómago, NO para diagnosticar hemorragia digestiva, no es contraindicación la sospecha de várices. Administrar en forma concomitante metoclopramida 10 mg IV (favorece el vaciamiento gástrico).
3. Posicionar cabeza a 45 grados, teniendo a la mano elementos de aspiración.
4. Continuar con el proceso de oxigenación descrito anteriormente, usando máscara de alto flujo.
5. Usar sedantes con poco compromiso en hemodinamia (etomidato, ketamina) a dosis bajas, la presión arterial suele ser baja en este grupo de pacientes, tanto por su patología de base como por el sangrado actual.
6. Administrar relajantes musculares, incluso a dosis altas. Tanto con la finalidad de acortar el tiempo de inicio como para aprovechar el aumento del tono en el esfínter esofágico inferior que conlleva su administración.
7. En caso de llegar a fallar en el primer intento (recordando que es una vía aérea difícil) retornar a ventilación con bolsa mascarilla, lentamente (cada 6 segundos) planterase la posibilidad de dispositivos supraglóticos.
8. En caso de emesis, posicionar en trendelenburg.
9. No olvidar, que posterior a ello, el paciente puede desencadenar una respuesta inflamatoria sistémica

aumentada[4].

B. Evaluar compromiso ventilatorio ¿inminencia de falla?

La presencia de hemorragia masiva se acompaña de alteración en oxigenación a nivel tisular, como mecanismo compensatorio aumenta la frecuencia respiratoria; en pacientes con poca reserva funcional (enfermos crónicos) puede presentarse fatiga e inminencia de falla ventilatoria.

No es solo la necesidad de protección de la vía aérea por el episodio de sangrado, sino también el desgaste y consumo de reservas calóricas que pueden llevar a necesidad de intubar a pacientes con sangrado digestivo.

C. Compromiso circulatorio

No solo la presencia de taquicardia o presión arterial baja reflejan compromiso a nivel circulatorio, al momento de valorar clínicamente a los pacientes, recordar que el estado de conciencia, llene capilar, la diferencia en la temperatura de las extremidades al tacto y la presencia de livideces (coloraciones violáceas en extremidades) entre otros, son marcadores clínicos de perfusión los cuales marcan la necesidad de acciones en forma inmediata.

Lo anterior, sumado a la presencia de sangrado activo determina actuar rápidamente.

Si hay compromiso circulatorio:

a Iniciar manejo con ácido tranexámico 1 g en 200 ml para pasar en 20 minutos[5].

b Trasfundir hemoderivados en relación 1:1:1 (Glóbulos rojos empaquetados: plasma: plaquetas). La coagulopatía basal por la disfunción hepática asociado a trombocitopenia, sumado al consumo por el sangrado activo plantean la necesidad de reponer todos los componentes hemáticos.

c El manejo con volumen debe ser cuidadoso, los pacientes cirróticos suelen llevar presiones arteriales bajas. Intentar recuperar valores de presión arterial con administración excesiva de líquidos podría empeorar los desenlaces.

d La meta de niveles de hemoglobina suele ser cercana a 7 g/dL[6].

e Inicio de inhibidores de bomba de protones IV en forma rápida (Aunque los trabajos iniciales fueron con infusión continua, se ha visto que no hay diferencia entre infusión continua y bolos intermitentes)[7]:
- Omeprazol (Amp 40 mg) 80 mg IV, luego 40 mg IV cada 6 horas

f Inicio temprano de antibióticos IV (pacientes con cirrosis y sangrado tienden a presentar múltiples infecciones en forma rápida)[8]:
- Ceftriaxona (Amp 1g) 2 g IV cada 24 horas

g Con alta sospecha de várices esofágicas inicio de agentes vasopresores (Sin diferencia entre octreótide o terlipresina)[9]:
- Octreotide (Amp de 100 mcg) 50 mcg en bolo, luego 50 mcg/h
- Terlipresina (Amp de 1 mg) 2 mg IV cada 4 horas

h Terapia endoscópica emergente

Las medidas de soporte médicas permiten estabilizar al paciente mientras es llevado a endoscopía, con el fin de evaluar el origen del sangrado y de ser posible, realizar medidas correctivas (clipaje, bandas en caso de várices esofágicas; escleroterapia o fulguración en otros tipos de sangrado).

Idealmente estas acciones deben llevarse a cabo **en el menor tiempo posible.**

En algunos casos, cuando no es posible controlar el sangrado (hasta 10% de las endoscopías fallan) o simplemente no se cuenta con ese recurso; el taponamiento con balón puede ser otra alternativa.

El problema radica en las complicaciones graves que puede tener su uso (ruptura esofágica, isquemia esofágica), por lo cual la relación riesgo-beneficio debe ser cuidadosamente evaluada.

En nuestro medio el balón de Sengstaken-Blakemore (con balón gástrico, esofágico y luz única de succión gástrica) es el más disponible. Si la situación clínica nos lleva a usar este tipo de sonda debemos pedir apoyo al equipo de cirugía o derivarlo al centro asistencial que disponga de este equipo.

D. Disposición

Dada la necesidad de manejo agresivo, multidisciplinario y la alta posibilidad de complicaciones, dentro de ellas muerte, se hace necesario continuar tratamiento en forma intrahospitalaria.

Encefalopatía hepática

La encefalopatía hepática es un continuo de disfunciones psiquiátricas y neurológicas, transitorias y reversibles propias de la cirrosis, que abarca desde casos leves y sutiles hasta el coma profundo[10].

Dado el abanico de cambios clínicos cognitivos que pueden observarse y la variabilidad propia de los pacientes, se describen frecuencias entre 20% a 80% de casos en personas cirróticas.

Su importancia radica, no solo en el impacto en la calidad de vida de los pacientes y sus cuidadores, asociándose a un incremento importante en costos de salud y necesidad de hospitalizaciones; sino también como importante factor de riesgo de mal pronóstico, describiéndose sobrevidas a 3 años de solo 23% en casos recurrentes[11].

Se trata de un diagnóstico de exclusión en pacientes con daño hepático, principalmente a las acumulaciones de productos nitrogenados (amonio), metabolismo de amonio a glutamina en el sistema nervioso central. Se relaciona con aumento en producción de desechos, incapacidad de eliminación y alteración en neurotransmisores[12].

En la siguiente tabla podemos revisar una Clasificación clínica de encefalopatía hepática:

Tabla 1. Clasificación clínica de encefalopatía hepática.

Grados	Nivel de conciencia	Hallazgos clínicos	Hallazgos neurológicos
0	Normal	Ninguno	Ninguno (valorar EHM)
1	Confusión leve	Cambio de humor, conducta inapropiada, déficit de atención, dificultad para elaborar ideas, irritabilidad, alteraciones del ciclo sueño/vigilia.	Temblor o asterixis leve
2	Letargia	Desorientación temporal, gran dificultad para practicar tareas mentales, cambio marcado de la personalidad.	Asterixis manifiesta, dificultad para hablar.
3	Estupor	Imposibilidad de realizar tareas mentales, desorientación en tiempo y espacio, amnesia, habla ininteligible, agitación psicomotriz.	Rigidez muscular y clonus, hiperreflexia.
4	Coma	Coma	Postura descerebración

Fuente: Cortés L, Córdoba J. 63 Encefalopatía hepática. (6):14.

Diagnóstico

Es importante al momento de evaluar a estos pacientes contar con la presencia de familiares o cuidadores debido a que permiten establecer el estado cognitivo basal y evaluar cambios discretos que puedan o no ser evidentes en la evaluación inicial del paciente.

Recordar que uno de los marcadores iniciales de encefaopatía hepática es el cambio en el patrón del sueño que algunas veces puede pasar desapercibido.

Dentro de los factores desencadenantes de la encefalopatía hepática destacan:

Dichos eventos no solamente pueden exacerbar la encefalopatía, sino directamente causar deterioro cognitivo, pero siempre debemos recordar que hay otras causas de "compromiso de conciencia" a considerar que si no las buscamos dirigidamente no las diagnosticaremos ni trataremos. Entre estas es importante descartar:

- Infecciones tanto del sistema nervioso central como de otro foco que esté causando sepsis.
- Sangrado intracerebral espontáneo o secundario a un traumatismo craneano.

En algunos casos, puede encontrarse amonio elevado[13], lo que apoyará el diagnóstico de encefalopatía hepática por sobre los diagnósticos diferenciales.

Tratamiento

El tratamiento de la encefalopatía hepática parte desde el mismo momento del diagnóstico, considerando que la identificación de el o los factores desencadenantes permite corregirlos.

1. Corregir la causa

a | Antibióticos, de acuerdo a la presunción del foco infeccioso (infección urinaria, peritonitis bacteriana espontánea entre otras).

b | En caso de hemorragias digestivas, realizar repleción de volumen, transfusiones e intervención temprana en corrección de las causas del sangrado.

c | Cuando se sospecha de pérdida de volumen intravascular o falla renal, recordar suspender diuréticos y considerar inicio de albúmina.

d | Corregir trastornos hidroelectrolíticos.

2. En forma simultánea, recordar el manejo de azoemia y edema cerebral, considerando estos dos puntos como base de las manifestaciones cognitivas.

a | Inicialmente aumentar la frecuencia de las deposiciones como vía de eliminación de nitrogenados por vía intestinal, se recomienda: Lactulosa 25 ml cada 1 a 2 horas hasta presentar deposiciones blandas.

b | Adicionalmente disminuir la producción de nitrogenados por parte de la flora intestinal, se utilizarán entonces antibióticos de acción endoluminal:
- Rifaximina 400 mg 3 veces al día
- Neomicina podría ser alternativa[14].

3. Pueden presentarse episodios de agitación, considerando el riesgo que ello conlleva se sugiere:

a | Haloperidol es la mejor alternativa para el tratamiento.

b | Evitar benzodiacepinas, dado el riesgo de recirculación y el metabolismo hepático (Vilstrup H., 2014), aumentando el riesgo de depresión respiratoria.

Disposición

Considerando la frecuencia de estas manifestaciones conviene definir el sitio adecuado para su manejo.

- Grado I podría ser dado de alta con recomendaciones generales, si es que la causa está identificada y corregida o es posible terminar su tratamiento de forma ambulatoria.
- Grado II manejo en sala de cuidados básicos
- Grado III y IV manejo en Unidad de manejo intensivo (UTI) o de mayor complejidad (Vilstrup H., 2014)

Peritonitis bacteriana espontánea

En un paciente con daño hepático, ascitis, la presencia de fiebre, dolor abdominal, encefalopatía hepática, diarrea o deterioro de su estado general conviene plantear la presencia de peritonitis bacteriana espontánea[15].

Siendo la presencia de dolor abdominal el signo más sensible (94.1%) y la alteración mental (95,3%) junto a la presencia de fiebre (90.1%) los más específicos en la búsqueda de dicho diagnóstico[16].

Manejo Inicial

Evaluar ABCD, incluir *hemoglucotest*; actuar acorde y corregir.

Pruebas diagnósticas

- Hemograma, evalúa respuesta inflamatoria, la presencia de trombocitopenia es predictora de peritonitis bacteriana espontánea.
- Proteína C reactiva. Valores altos (mayores a 60), pudieran ser predictores de una peritonitis.
- Panel metabólico, considerar otras entidades.
- Radiografía de tórax, orina completa, si hay sospecha de otro foco infeccioso.

Paracentesis: Su realización en forma rápida e inicio de terapia acorde, ha demostrado disminución tanto en mortalidad como en días de estancia hospitalaria[17].

El diagnóstico de peritonitis bacteriana espontánea se basa en la presencia en líquido ascítico de más de 250 neutrófilos/mm3, más de 1000 leucocitos/mm3, cultivos positivos.

Al momento de realizar la paracentesis se debe tomar 3 muestras:

- En el primero de realiza gram del líquido y citoquímico.
- El segundo para cultivo.
- Una tercera muestra para estudios adicionales.

Tratamiento

En pacientes con sospecha de peritonitis bacteriana espontánea y más de 250 neutrófilos/mm3 deberían recibir (alguno de los dos esquemas):

- Ceftriaxona 2 g IV cada 24 horas
- Cefotaxima 2 g IV cada 8 horas

Si conteo menor a 250 neutrófilos/mm3 pero con signos clínicos de infección, deberían recibir mismo tratamiento hasta obtener cultivos[18].

La presencia de glucosa baja (menos de 50 mg/dL), proteínas totales mayores a 1 g/dL, LDH mayor a 225 mU/mL (Criterios de Runyon); antígeno carcinoembrionario o fosfatasa álcalina; en líquido ascítico debe hacer pensar en peritonitis bacteriana secundaria.

Se recomienda estudio con tomografía computarizada de abdomen y definir necesidad de manejo quirúrgico[19]; ampliando cobertura para gérmenes anaeróbicos.

En este caso deberían recibir, adicional a lo anteriormente descrito: Metronidazol 500 mg IV cada 8 horas.

Disposición

Ante la presencia de peritonitis bacteriana, se recomienda manejo intrahospitalario.

Síndrome Hepatorrenal

Se caracteriza por un deterioro en la función renal en la presencia de daño hepático avanzado.

Cerca del 40% de los pacientes lo presentan en los primeros 5 años de curso de la enfermedad, siendo siempre un diagnóstico de exclusión. Se ha relacionado a disfunción en flujo sanguíneo renal secundario a vasodilatación esplácnica[20,21].

Dado el descenso en flujo renal, se presenta baja excreción de sodio, caída en la capacidad de filtración glomerular con consecuente oliguria y elevación de creatinina[22,23].

Se distinguen 2 tipos, síndrome hepatorrenal tipo 1 con aumento en creatinina más de 2 veces el basal del paciente en un plazo de 2 semanas y síndrome hepatorrenal tipo 2 que se desarrolla en un tiempo mayor. Recordando que son diagnósticos de exclusión, es decir, descartando otras causas de deterioro en función renal[24].

Diagnóstico

Siendo un diagnóstico de exclusión, su presentación en el servicio de urgencias usualmente es al mismo tiempo que otras entidades que generan mayor premura en su manejo. Aun así, conviene recordar criterios diagnósticos[25]:

- Daño hepático crónico acompañado de cirrosis.
- Creatinina mayor a 1,5 mg/dL.
- Sin mejoría después de 48 horas de manejo con expansión de albúmina y suspendiendo diuréticos.
- Ausencia de shock.
- Excluyendo uso de nefrotóxicos.
- Ausencia de proteinuria, hematuria o anomalía anatómica renal.

Tratamiento

Considerando que la vasodilatación esplácnica desempeña papel fundamental en el desarrollo de este síndrome, es piedra angular en el manejo médico el uso de vasoconstrictores, recomendándose:

Terlipresina 1 mg IV cada 6 horas. De no estar disponible, Octreotide 50 mcg/h IV durante las primeras 24 horas.

En pacientes con inestabilidad hemodinámica, podría optarse por:

- Noradrenalina 0,5 mg/h hasta controlar hipotensión.

La expansión de volumen puede hacerse con:

- Albúmina 1g/kg cada 12 horas (recordando que la no mejoría con albúmina es uno de los criterios diagnósticos).

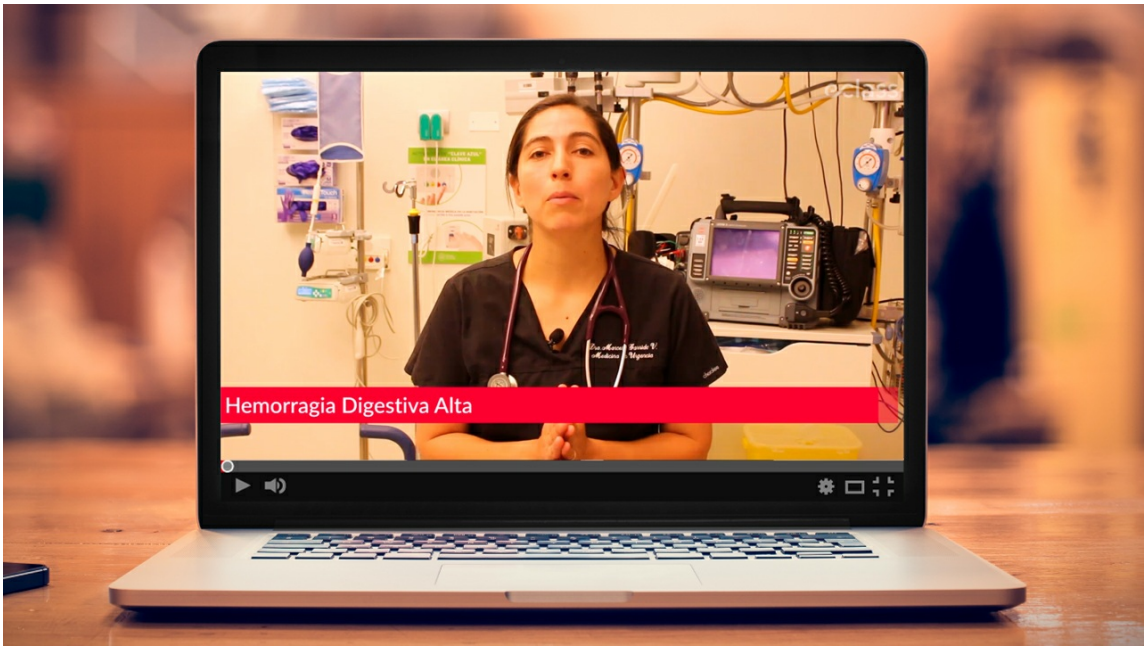
Esta terapia con vasopresores (terlipresina, octreotide o noradrenalina) sumado a la expansión de volumen con albúmina conlleva a mejoría del síndrome hepatorrenal hasta en un 60% de los casos, en los restantes se ha postulado que la terapia de reemplazo renal (hemodiálisis) podría usarse como puente al manejo definitivo (trasplante hepático) se describen casos que revierte con la terapia vasoconstrictora[25].

Puntos Principales

- La hemorragia digestiva alta en paciente con daño hepático conlleva un manejo agresivo de reanimación requiriendo intervención endoscópica temprana, uso de antibióticos y con frecuencia, soporte transfusional.
- La peritonitis bacteriana espontánea debe sospecharse en pacientes con daño hepático y ascitis que presentan deterioro de su estado general, su diagnóstico se basa en la realización de paracentesis y el inicio de antibiótico en forma temprana es fundamental.
- Aquellos pacientes con daño hepático crónico que ingresen con alteración de su estado mental (en ocasiones, signos tan sutiles como alteración del ciclo sueño - vigilia) deben ser evaluados con el fin de descartar encefalopatía hepática, estudiando algunos factores desencadenantes como lo son infecciones, seguimiento en la terapia crónica e incluso hemorragias digestiva.
- El síndrome hepatorrenal, constituye una complicación relativamente frecuente (40%) en los pacientes con daño hepático avanzado, si bien es un diagnóstico de exclusión, conviene buscarlo en forma activa ya que la terapéutica instaurada permite disminuir en alto grado la morbimortalidad a mediano plazo.
- El daño hepático crónico conlleva una serie de cuadros de descompensación agudos que ocasionan atención en urgencias, siendo varios de ellos cuadro con alto riesgo vital.
- Conviene reconocerlos en forma temprana e iniciar maniobras de tratamiento que permitan disminuir la morbimortalidad en este grupo de pacientes que de por sí, se encuentran en estado funcionales generalmente deteriorados.

llene capilar: Para realizar esta maniobra se presiona el dedo índice que se torne blanco, presionar durante 10 segundos cronometrando el tiempo en que retoma al color rosado inicial. Lo normal es que demore hasta 3 segundos..

Video Hemorragia digestiva alta



Vea este video en la versión online de la clase.

Bibliografía Unidad 3

- Pant C, Olyaee M, Gilroy R, Pandya PK, Olson JC, Oropeza-Vail M, et al. Emergency Department Visits Related to Cirrhosis: A Retrospective Study of the Nationwide Emergency Department Sample 2006 to 2011. Medicine (Baltimore). 2015 Jan;94(1):e308.
- Téllez-Ávila FI, Chávez-Tapia NC, Torre-Delgadillo A. Trastornos de coagulación en el cirrótico. Revista de investigación clínica, 59(2), 153-160. Recuperado de http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-83762007000200010&lng=es&tlng=es.
- Sigal S, Mitchell O, Feldman D, Diakow M. The pathophysiology of thrombocytopenia in chronic liver disease. Hepatic Med Evid Res. 2016 Apr;39.
- Wrenn EA, Wohlers R, Montgomery M, Cobb H, Condra J, Tharpe S, et al. Comparison of Flow Dynamics of Peripherally and Centrally Inserted Intravenous Catheters Using a Rapid Infusion System (ThermaCor 1200).
- Weingart S. EMCrit Podcast 5 – Intubating the Critical GI Bleeder. EMCrit [Internet]. 2009 Jun;21. Available from: http://emcrit.org/podcasts/intubating-gi-bleeds/.
- Tavakoli N, Mokhtare M, Agah S, Azizi A, Masoodi M, Amiri H, et al. Comparison of the efficacy of intravenous tranexamic acid with and without topical administration versus placebo in urgent endoscopy rate for acute gastrointestinal bleeding: A double-blind randomized controlled trial. United Eur Gastroenterol J. 2018 Feb;6(1):46–54.
- Villanueva C, Colomo A, Bosch A, Concepción M, Hernandez-Gea V, Aracil C, et al. Transfusion strategies for acute upper gastrointestinal bleeding. N Engl J Med. 2013;368(1):11–21.
- Sachar H, Vaidya K, Laine L. Intermittent vs Continuous Proton Pump Inhibitor Therapy for High-Risk Bleeding Ulcers: A Systematic Review and Meta-analysis. JAMA Intern Med. 2014 Nov 1;174(11):1755.
- Lee YY. Role of prophylactic antibiotics in cirrhotic patients with variceal bleeding. World J Gastroenterol. 2014;20(7):1790.
- Seo YS, Park SY, Kim MY, Kim JH, Park JY, Yim HJ, et al. Lack of difference among terlipressin, somatostatin, and octreotide in the control of acute gastroesophageal variceal hemorrhage. Hepatology. 2014 Sep;60(3):954–63.
  Ridola L. The burden of minimal hepatic encephalopathy: from diagnosis to therapeutic strategies. Ann Gastroenterol [Internet]. 2018 [cited 2019 Jan 28]; Available from: http://www.annalsgastro.gr/files/journals/1/earlyview/2018/ev-02-2018-01-AG3192-0232.pdf
- Bustamante J, Rimola A, Ventura P-J, Navasa M, Cirera I, Reggiardo V, et al. Prognostic significance of hepatic encephalopathy in patients with cirrhosis. J Hepatol. 1999;30(5):890–895.
- Eroglu Y, Byrne WJ. Hepatic Encephalopathy. Emerg Med Clin North Am. 2009 Aug;27(3):401–14.
- Cortés L, Córdoba J. 63 Encefalopatía hepática. (6):14.
- Khungar V, Poordad F. Hepatic Encephalopathy. Clin Liver Dis. 2012 May;16(2):301–20.
- Vilstrup H. Hepatic Encephalopathy in Chronic Liver Disease: 2014 Practice Guideline by AASLD and EASL. 2014;74.
- Hepatitiscuwedu. Core Concepts - Recognition and Management of Spontaneous Bacterial Peritonitis - Management of Cirrhosis-Related Complications - Hepatitis C Online. In: [online] Available at: https://www.hepatitisc.uw.edu/go/management-cirrhosis-related-complications/spontaneous-bacterial-peritonitis-recognition-management/core-concept/all [Accessed 26. 2018.
- MacIntosh T. Emergency Management of Spontaneous Bacterial Peritonitis – A Clinical Review. Cureus [Internet]. 2018 Mar 1 [cited 2018 Dec 5]; Available from: https://www.cureus.com/articles/9625-emergency-

management-of-spontaneous-bacterial-peritonitis---a-clinical-review

- Gaetano JN, Micic D, Aronsohn A, Reddy G, Te H, Reau NS, et al. The benefit of paracentesis on hospitalized adults with cirrhosis and ascites. J Gastroenterol Hepatol. 2016;31(5):1025–1030.
- Runyon BA. Management of Adult Patients with Ascites Due to Cirrhosis: Update 2012. 2012;96.
- Holguín Cardona A, Hurtado Guerra JJ, Restrepo Gutiérrez JC. Una mirada actual a la peritonitis bacteriana espontánea. Rev Colomb Gastroenterol. 2016 Dec 5;30(3):315.
- Ginès P, Guevara M, Arroyo V, Rodés J. Hepatorenal syndrome. Lancet 2003; 362:1819.
- Wadei HM, Mai ML, Ahsan N, Gonwa TA. Hepatorenal syndrome: pathophysiology and management. Clin J Am Soc Nephrol. 2006;1:1066.
- Arroyo V, Ginès P, Gerbes AL. Definition and diagnostic criteria of refractory ascites and hepatorenal syndrome in cirrhosis. Int Ascites Club Hepatol. 1996;23:164.
- Velez JC, Nietert PJ. Therapeutic response to vasoconstrictors in hepatorenal syndrome parallels increase in mean arterial pressure: a pooled analysis of clinical trials. Am J Kidney Dis. 58:928.
- Salerno F, Gerbes A, Gines P, Wong F, Arroyo V. Diagnosis, prevention and treatment of hepatorenal syndrome in cirrhosis. Postgrad Med J. 2008 Dec 1;84(998):662–70.